

Enfermedad celíaca

1. Introducción y relevancia clínica

La **enfermedad celíaca (EC)** es una **enteropatía autoinmune crónica** desencadenada por la **ingestión de gluten** (proteína presente en trigo, cebada, centeno y avena contaminada), en individuos genéticamente susceptibles (portadores de HLA-DQ2 o DQ8).

Su principal característica es la **atrofia de las vellosidades del intestino delgado**, con malabsorción de nutrientes.

En pediatría, puede manifestarse desde los primeros meses de vida hasta la adolescencia, con **síntomas digestivos (diarrea, distensión, baja de peso)** o **manifestaciones atípicas** (anemia, talla baja, constipación, alteraciones dentarias).

En Chile, la prevalencia estimada es cercana al **1 % de la población**, y se ha incrementado gracias a la **búsqueda activa con anticuerpos específicos (anti-transglutaminasa IgA)**.

En el **EUNACOM**, este tema aparece en casos clínicos donde un niño con **talla baja, anemia microcítica y diarrea crónica** presenta anticuerpos positivos, y se pregunta por el diagnóstico o el manejo dietético.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Mecanismo inmunológico

1. El **gluten** (particularmente su fracción “gliadina”) es parcialmente digerido.
2. En individuos con predisposición genética (HLA-DQ2/DQ8), la gliadina se **desamida** por la **enzima transglutaminasa tisular (tTG)**.
3. Este complejo gliadina–tTG activa linfocitos T CD4+, desencadenando una **respuesta inflamatoria crónica en la mucosa intestinal**.
4. El daño resultante produce **atrofia de vellosidades, hiperplasia de criptas y linfocitosis intraepitelial**.

b. Consecuencia: malabsorción

- Pérdida de superficie absorptiva.

- Deficiencia de hierro, folato, calcio, vitaminas liposolubles.
 - Alteraciones del crecimiento y desarrollo.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

La presentación varía con la edad:

a.

Forma clásica (digestiva)

Aparece entre los **6 y 24 meses**, luego de la introducción del gluten:

- Diarrea crónica, deposiciones voluminosas y malolientes.
- Distensión abdominal, meteorismo.
- Anorexia, irritabilidad.
- Baja de peso y detención del crecimiento.
- Atrofia muscular glútea (“nalgas planas”).

b.

Forma no clásica (extradigestiva o atípica)

- Talla baja o falla de crecimiento.
- Anemia ferropénica refractaria.
- Osteopenia/osteoporosis.
- Aftas orales recurrentes.
- Hipertransaminasemia leve.
- Pubertad retrasada.
- Alteraciones del esmalte dentario.

c.

Forma silente o subclínica

- Sin síntomas evidentes, pero con anticuerpos positivos y daño histológico intestinal.
- Se detecta en tamizaje por antecedentes familiares o patologías asociadas.

d.

Asociaciones frecuentes

- Diabetes mellitus tipo 1.
- Tiroiditis autoinmune.
- Síndrome de Down.
- Síndrome de Turner.
- Déficit de IgA selectivo.

e. Diagnóstico diferencial

Patología	Diferencia clave
Intolerancia a lactosa	Sin anticuerpos, síntomas postprandiales.
Fibrosis quística	Esteatorrea + infecciones respiratorias recurrentes.
Giardiasis crónica	Protozoos en coproparasitológico.
Desnutrición primaria	Sin anticuerpos ni alteración de mucosa intestinal.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico de enfermedad celíaca se basa en **la combinación de hallazgos clínicos, serológicos, genéticos e histológicos**.

a.

Pruebas serológicas

Examen	Interpretación
Anticuerpos anti-transglutaminasa tisular (tTG IgA)	Prueba más sensible y específica (>95 %).
Anticuerpos anti-endomisio (EMA IgA)	Muy específicos, se usan para confirmar.
Anticuerpos anti-gliadina (AGA IgA/IgG)	Menos específicos, útil en menores de 2 años.
IgA sérica total	Fundamental: la deficiencia de IgA produce falsos negativos.
En deficiencia de IgA → solicitar tTG IgG o deamidated gliadin peptide (DGP IgG) .	

b.

Confirmación diagnóstica

- Si los anticuerpos son positivos → realizar **biopsia duodenal** (endoscopía alta).
- Hallazgos histológicos según **clasificación de Marsh**:

Tipo	Hallazgo histológico
------	----------------------

Marsh 0 Normal

Marsh 1 Linfocitosis intraepitelial

Marsh 2 Hiperplasia de criptas

Marsh 3 Atrofia vellosa parcial o total

Diagnóstico confirmado con Marsh 2–3 + anticuerpos positivos.

C.

Excepciones (Guías ESPGHAN / SOCHIFE / MINSAL 2024)

En niños sintomáticos con:

- **tTG IgA >10 veces el valor normal**
- **EMA IgA positivo**
- **HLA-DQ2 o DQ8 positivo**

□ puede diagnosticarse **sin biopsia**.

d.

Exámenes complementarios para evaluar repercusión

- Hemograma (anemia microcítica o normocítica).
- Ferritina, folato, vitamina B12.
- Calcemia, fosfatasas alcalinas.
- TSH y T4 libre (descartar tiroiditis asociada).
- Densitometría ósea en casos prolongados.

5. Tratamiento (según Guía MINSAL / SOCHIPE 2024)

a.

Dieta sin gluten (DSG) estricta y de por vida

Excluir **trigo, cebada, centeno y avena contaminada**.

Permitidos: arroz, maíz, papa, mandioca, quinoa, amaranto.

Prohibidos: pan, galletas, pastas, productos industriales con trazas de gluten.

Incluso pequeñas cantidades (<20 ppm) pueden reactivar la enfermedad.

b.

Corrección de déficits nutricionales

- Hierro, ácido fólico, vitamina B12.
- Calcio y vitamina D.
- Suplementos proteicos si desnutrición.

c.

Vacunación

Pacientes con hipoesplenismo funcional pueden requerir **vacuna antineumocócica**.

d.

Apoyo nutricional y educativo

- Supervisión por **nutricionista** con experiencia en DSG.
 - Educación familiar sobre lectura de etiquetas (“libre de gluten”).
 - Seguimiento médico periódico (crecimiento, serología, adherencia).
-

6. Seguimiento

Control	Objetivo
Cada 3–6 meses el primer año	Evaluar adherencia, crecimiento, síntomas.
Anticuerpos tTG o EMA	Deben negativizarse en 6–12 meses.
Laboratorio nutricional	Controlar hierro, vitaminas, calcio.
Reevaluar dieta	Asegurar ausencia de gluten oculto.
Si los anticuerpos no se negativizan → sospechar incumplimiento dietético o diagnóstico alternativo.	

7. Complicaciones y pronóstico

a.

Complicaciones por diagnóstico tardío o incumplimiento

- Desnutrición crónica.
- Baja talla.
- Osteopenia / osteoporosis.
- Infertilidad o amenorrea secundaria.
- Linfoma intestinal de células T (raro).
- Adenocarcinoma del intestino delgado.

b.

Pronóstico

Excelente con **adhesión estricta a la dieta sin gluten**.

El daño intestinal es **reversible** y el crecimiento suele normalizarse en 6–12 meses.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **Anticuerpo más sensible y específico:** anti-transglutaminasa IgA.
2. Si **IgA total baja**, solicitar **tTG IgG o DGP IgG**.
3. **Biopsia duodenal** confirma el diagnóstico, salvo en casos con títulos >10x.
4. **Tratamiento exclusivo:** dieta sin gluten estricta y de por vida.
5. La **anemia ferropénica refractaria** es una forma frecuente de presentación.
6. **Asociación con DM1 y tiroiditis autoinmune:** tamizaje anual.
7. **HLA-DQ2/DQ8 negativo** prácticamente descarta la enfermedad.

☐ Errores frecuentes:

- Iniciar dieta sin gluten antes de confirmar diagnóstico (falsos negativos).
 - Interpretar títulos bajos de anticuerpos sin clínica.
 - No medir IgA total.
 - No indicar seguimiento serológico.
 - Pensar que la dieta puede suspenderse tras normalización.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **enfermedad celíaca** es una enteropatía autoinmune inducida por el **gluten** en individuos HLA-DQ2/DQ8 positivos.
2. Se presenta con **diarrea crónica, distensión, anemia o talla baja**.

3. Diagnóstico: **anticuerpos anti-transglutaminasa IgA y biopsia duodenal (Marsh 2–3).**
4. En casos con títulos >10x + EMA positivo → se puede omitir biopsia.
5. Tratamiento: **dieta sin gluten de por vida.**
6. Los anticuerpos deben **negativizarse en 6–12 meses.**
7. Complicaciones graves se evitan con diagnóstico y adherencia precoz.